



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : نادية محمود حسنى طاهر
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : اخرى
رقم البطاقة : 26604170101708 رقم التليفون : 01037929999
العنوان : الرحاب
العمر (تاريخ الميلاد) : 17-04-1966 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 06-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مسح ذري علي العظام [12966] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نادية محمود حسنى طاهر National ID: 26604170101708	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الى Bone scintigraphy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

131 p

ناديه
محمود حسنى طاهر
ش الساسول مجازين سيسى
قصر النيل - القاهرة

٢٦٦.٤١٧.٠١.١٧.٠٨

KY1825220

٢٠٢٤/١٢ ٢٦٦.٤١٧.٠١.١٧.٠٨
حاصلة على بكالوريوس تجارة
مصلحة
البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/١٢/٣٠

عزرا

A Patient ID:
1. Name: **أحمد محمد علي**
2. ID number: **266041/0101708**

Sex:

MDT form
3. Medical number:
Female
Patient Age: **57 Y**

83082661
04 Med:

2426/2022

Family history: **-VE**

Stage:

Marital status:

01072297259

811

Comorbidity:

HEH

NRE Score

01322150245

GROUP

Management status

POSTMENOPAUSE

REASON OF MDI POST OPERATIVE

Date of MDI **05/02/2023**

Breast Imaging:

Clinical data

Mets Workup: **FREE**

BX:

IDC

ER:

0/8

PR:

0/8

Her 2 Neu:

0

SISH:

NGT:

5

T

CT4B

N

1

M

1

Sonomammography:

LT UOQ 2-4 MULTIFOCAL 5*2.3* NON SPECIFIC AXILLARY
CESM: MULTICENTRIC (BIRADS 6)

PATIENT HISTORY

SHE WAS CT4b N1 M0--> LOCALIZED SKIN RETRACTION
SHE RECEIVED 6 NEOADJ AI

NEW SM 2/3/2023: PARTIAL RESPONSE OF LT MULTICENTRIC LOCALLY ADV. UOQ MASS
(1.9*3CM VS 2.3*5.5CM)

LT breast cancer II MRM

IDC G 2 cellularity 70

free deep margin

free nipple & areola

eye metastatic deposits in 3 LN s 3/17 with extracapsular invasion

partial pathological response

YPT2, ypN1

MDT OUTCOME & PLAN

4 CYCLES DOCEAXEL ENDOXAN, PORT, restart hormonal after end of chemo

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

Psychiatric

SIGNATURE

RADIOLOGY

PATHOLOGY

Nutrition

Name: ناديه محمود حسني طاهر		
MR. : 5457		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحية طيبة وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	
	رقم طبي:	بقسم:
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient is a 59-year-old individual with a history of left-sided breast cancer, invasive ductal carcinoma, grade II, estrogen receptor 8/8 positive, progesterone receptor 8/8 positive, HER2-negative, staged cT4bN1M0. The patient received neoadjuvant hormonal therapy followed by a left modified radical mastectomy in April 2023 (pathology T2, pN1, 3 of 17 lymph nodes positive). Adjuvant chemotherapy was administered consisting of four cycles of taxotere plus endoxan, after which the patient was placed on a femara (letrozole) regimen beginning in August 2023. The patient also received calcium supplementation (1 × 1 × 90) and a single dose of Zometa 4 mg in April 2024. Current management includes continuation of femara. The patient presented for femara administration only, noting that a dental procedure was performed two weeks prior. No changes to the treatment plan were made.		
تحريراً في ,		
	الوقت :	التاريخ : 20-09-2026
	الطبيب المعالج : ايه مدحت بدوي محمد	
يعتمد ,		



Patient Name : الأستاذة / نادية محمود حسني طاهر
Patient No. : 26604170101708
Path No. : 1817/2022
Sex : Female
Age : 56 Y
Referring Doc. :
Request No. : 13003696
Request Date : 27/06/2022
Verification Date : 25/07/2022
Financial Category : اورام دار السلام - ميانرد
Department : Out Patient
IHC No. :
Registered by : marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical data:
Left breast lesion

Nature of specimen:
Tru cut biopsy, collected at 27/6/2022 , 11:35 am

Gross examination:
4 greyish white & hemorrhagic tissue cores up to 2cm , totally submitted.
Immunohistochemical technique: Sections prepared from paraffin block for immune- staining using
Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (SP1), PR clone (1E2), HER-2 CLONE (4B5),
& Ki67 (30-9).

Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma .
- Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis) : (3+2+1) Grade II
- DCIS: No
- LVI: No
- Perineural invasion : No
- IHC:

Examination of ER stained slide show intense nuclear staining in 90% of the tumor cells.
Examination of PR stained slide show intense nuclear staining in 90% of the tumor cells.
Examination of HER2 stained slide show no membranous staining in the tumor cells.
Examination of Ki67 stained slide show nuclear staining in 5% of tumor cells.

Positive tissue control showed appropriate reactivity

Diagnosis

Verified by :
DR Menna Nabil

Printing Date : 25.07.2022 14:09:02

Page 1 of 2

Printed By : dr. Enas

Patient Name الأستاذة / نادية محمود حسني طاهر
Patient No. 26604170101708
Path No. 1817/2022
Sex Female
Age 56 Y
Referring Doc.

Request No. 13003696
Request Date 27/06/2022
Verification Date 25/07/2022
Financial Category اورام دار السلام - ميانرة
Department Out Patient

Registered by marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

- Left breast mass , Tru cut biopsy.
• Invasive duct carcinoma, Grade II .
• IHC:
• ER: Positive (score 8/8).
• PR: Positive (score 8/8).
• HER-2: Negative (score 0).
• Ki67: Positive in 5% of tumor cells.

Prof. Amal Hareedy
Dr. Menna Nabil

د. أمال هاردي
د. منة نabil

Verified by :
DR Menna Nabil

Printing Date : 25.07/2022 14:09:02

Page 2 of 2

Printed By : dr Enas

Patient Name : **مروى محمد يوسف**
Patient No : **26604170101705**
Patn No : **1052/2023**
Sex : **Female**
Age : **56 Y**
Referring Doc :
Request No : **13005322**
Request Date : **05/04/2023**
Verification Date : **10/04/2023**
Financial Category : **مستشفى**
Department : **Out Patient**
Registered by : **marwa mohamed youss**

Pathology Report

Clinical Data:

Left breast cancer post NACT

Nature of the specimen

Left MRM

Gross Examination:

- Procedure: L1 MRM specimen measured **26x17x5 cm**, Covering skin ellipse measured **21x13 cm**
- Tumor extent: A greyish white ill defined rubbery to firm tumour bed site measured **2.5x2x2.2 cm**
- Skin involvement: Nipple and areola were unremarkable grossly
- Distance from margins: 3.5 cm away from deep margin & 2.5 cm away from the skin
- Lymph nodes number and size: A fibrofatty tissue piece measured **9x6 cm** enclosing 17 LNs up to 1x1 cm.

Microscopic examination

- Histological type: Invasive duct carcinoma (cellularity 70%)
- Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): **G II (3+2+1)**
- Ductal carcinoma in situ: Focal, Low grade (cribriform pattern) 5%
- Positive perineural invasion
- Skin involvement: Free nipple and areola
- Lymph node involvement: Positive metastatic deposits in 3 LNs (3/17), with extracapsular invasion
- Resection Margins: Free deep margin
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response
- Additional pathologic findings: Microcalcification

Diagnosis:

Left breast cancer, Left MRM:

Verified by:
dr. estaa magdy

Printing Date: 18/04/2023 11:27:59

Page 1 of 2

Printing By: marwa mohamed youss



Total DLP (mGy cm)

Patient Name: Nadia Mahmoud Hosny	Date : 11/05/2024
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 58 Year(s)
Medical ID: 2426/2022	Pat. ID: 14358

**POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE
CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -**
Compared to last study dated 29/6/2022

Findings:

I Chest:-

- Interval left MRM with post operative scarring. No definite residual or recurrence.
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- Prominent left supracavicular lymph node.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous low CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Two Gall bladder stones reaching about 1 cm.
- Patent homogenously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.